



INFORME DE EVALUACIÓN DE CONDUCTA ALIMENTARIA TERAPIA OCUPACIONAL – FONOAUDIOLOGÍA

1. ANTECEDENTES PERSONALES:

Nombre	Gustavo Araya Kurte
Fecha de nacimiento	02 de enero 2021
Edad	3 años 11 meses
Escolaridad	Pre kínder - Rendic
Fecha de evaluación	Enero 2025
Motivo de consulta	Dificultades asociadas a conducta alimentaria

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

- ☐ Entrevista semiestructurada con los padres.
- ☐ Observaciones clínicas no estructuradas de Integración Sensorial.
- ☐ Observación libre de Juego.
- ☐ Sensory Processing Measure segunda edición – hogar.
- ☐ Pautas de elaboración propia respecto a conducta alimentaria.
- ☐ Pautas de elaboración propia en Motricidad orofacial

3. ANTECEDENTES RELEVANTES DE SALUD Y FAMILIARES:

Gustavo nació mediante parto por cesárea a las 35 semanas de gestación por ser un parto gemelar. Su peso fue de 2,400 kg y su talla de 47 cm, fue un embarazo controlado y sin dificultades. En cuanto a los antecedentes mórbidos, Gustavo presenta rinitis alérgica, los padres señalan que sufre de sinusitis recurrentes, no ha sido hospitalizado, cuando se enfermaba solía retroceder respecto a la alimentación. En cuanto a los hitos del desarrollo psicomotor la madre indica que este fue dentro de lo esperado, comenzando su marcha al año. Gustavo fue diagnosticado de ARFID, por la Nutrióloga Verónica Cárdenas en agosto de 2024, quien realiza derivación a evaluación de la conducta alimentaria. Gustavo asistió durante el segundo semestre del año 2023 a evaluación e intervención con Terapeuta ocupacional por derivación del jardín.

Gustavo forma parte de una familia nuclear biparental. Vive junto a su madre, Nicole Kurte (39 años, Ingeniera civil industrial), su padre Cristian Araya (43 años, Ingeniero en prevención) y su hermano mellizo Alonso. Ambos padres trabajan, por lo cual durante el día los cuidados de Gustavo y su hermano están a cargo de la nana, durante el fin de semana ambos padres se hacen cargo de los cuidados de los menores.

Espacio terapéutico **Sisu**

Área de Conducta alimentaria y desafíos en alimentación
comamosjuntos.antof@gmail.com
Antofagasta



4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

❖ GENERALIDADES

Habilidades de Comunicación, Lenguaje y Hablar: Gustavo se comunica mediante frases simples y complejas, logra responder preguntas sin dificultad; logra realizar relatos. En cuanto a las habilidades de imitación, logra realizar imitación motora, imitación de gestos y sonidos. Logra identificar y nominar alimentos, objetos de uso común, entre otros. Referente a la comprensión de ordenes Gustavo logra comprender ordenes simples y complejas y las realiza sin problemas. En cuanto al habla Gustavo presenta un habla inteligible.

Observación de la conducta: Gustavo durante las sesiones de evaluación participa activamente frente a las actividades presentadas, sin embargo, cuando algo no le gusta menciona inmediatamente que no es de su agrado de forma verbal, no obstante, realiza de igual manera la actividad. Logra realizar de forma adecuada transiciones de una actividad a otra, lo mismo ocurre cuando se cambia de un espacio físico a otro.

Juego / Intereses: Gustavo es un niño con un nivel de actividad optimo, explora el ambiente activamente y los materiales dispuestos en él. Le gusta jugar en conjunto con las terapeutas, respeta turnos simples. En cuanto a la atención conjunta durante las actividades de juego esta es funcional, los tiempos de juegos son adecuados, sus habilidades de imitación son adecuadas.

Dentro de los intereses en el espacio terapéutico, se pueden mencionar; señor cara de papas indica que es su juguete favorito, cama elástica. Dentro de los intereses señalados por la madre, se encuentran; bailar, saltar, superhéroes de Marvel, dinosaurios, cantar, libros, salir al parque, dibujar y nadar.

Habilidades Motoras: Gustavo se desplaza de manera independiente en las salas terapéuticas, camina, corre, salta, sube y baja de materiales, en ocasiones choca con las cosas a su alrededor de manera desorganizada. A nivel motor fino, logra realizar manipulaciones y prensiones simples y funcionales, toma y sostiene elementos de diversos tamaños, formas y peso, la coordinación óculo manual se aprecia levemente descendida para la edad. En relación a la alimentación, Gustavo hace uso de la cuchara en ocasiones con una menor planificación motriz, sus tomas no siempre le resultan eficientes y cómodas, incluso cuando esto le implica hacer un mayor esfuerzo muscular.

❖ ANÁLISIS DE CONDUCTA ALIMENTARIA

Historia Clínica de la Conducta Alimentaria:

Gustavo al momento de nacer recibió leche de formula y posteriormente se mantuvo con lactancia mixta, no se presentaron dificultad en el acople. La lactancia materna duró hasta los 2 años 5 meses. Utilizó cuando pequeño muy poco el chupete y también utilizó mamadera para la leche de formula. La alimentación complementaria (AC) inició a los 6 meses mediante papillas, la transición hacia



texturas más sólidas comenzó aproximadamente a los 8 meses. Madre señala que los problemas de alimentación se han presentado siempre, desde que inició la AC vomitaba repetidamente. Presentaría según la madre dificultades para masticar alimentos y posteriormente tragarlos. Frecuentemente muerde objetos (lápices, monitos, gomas, juguetes, etc.) y se come las uñas. Gustavo acepta comida tipo crema, papilla y algunos colados, no acepta nada salado que se deba masticar según señala su padre. El año pasado fue diagnosticado con ARFID (trastorno evitativo/restrictivo de la ingesta alimentaria) por la Nutrióloga. Previamente al diagnóstico, madre refiere haber sentido tristeza, preocupación y frustración, lo que la impulsa a solicitar la evaluación, actualmente estos sentimientos han disminuido en cierta forma al ir comprendiendo un poco más respecto a lo que le sucede a su hijo.

Descripción Ambiental:

Gustavo suele comer en la mesa del comedor junto a su hermano, nana o padres. En el comedor, queda con los pies colgando de la silla. También utiliza su silla de comer, en ésta cuenta con apoyo para sus pies. En las horas de comidas, se evita el uso de distractores, suelen utilizarse libros o juguetes a veces. Antes si utilizaban pantallas, pero las quitaron. El lugar donde come tiene una adecuada iluminación.

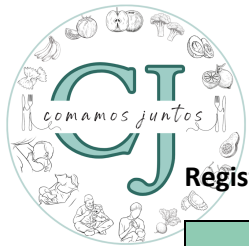
Rutina:

Gustavo no tiene una rutina previa establecida de alimentación, que le permita anticiparse. Participa en la elaboración de alimentos, sin embargo, no los consume, participa de las compras en el supermercado con los padres.

El día habitual de Gustavo es descrito por la madre como; *de lunes a viernes desayuna a las 07:00 am. Nestum con leche junto a su hermano en el comedor, durante los fines de semana desayuna a las 09:00 am. un Brownie junto a su hermano y madre en el comedor. En la época escolar Gustavo almuerza alrededor de las 12:00 pm. hasta las 13:00 pm. en el casino del establecimiento educacional, en casa algunas ocasiones almuerza solo o con su hermano y el fin de semana almuerzan todos junto. Su cena es alrededor de las 19:00 pm, normalmente come con su hermano. En cuanto a las colaciones realiza una a media mañana esta puede ser leche, galleta, yogurt o compota de frutas, se toma una leche a las 15.00 pm y otra colación a las 17:00 pm y su última leche es en la noche antes de irse a dormir.*

Independencia:

Gustavo sabe comer por sí solo, cuenta con las habilidades motrices para ello, sin embargo, muchas veces prefiere que un tercero le dé la comida y lo solicita. Utiliza cuchara, no utiliza tenedor, usa vaso abierto y con bombilla.



Registro de alimentación durante 5 días:

Día 1	Día 2	Día 3
- Brownie. - Yogurt con cereal - Compota de plátano. - Helado Chocolito. - Tomaticán (por cedazo) y galletas. - Leche de frutilla. - Galletas Oreo. - Mini Chocolito. - Sopa de pavo con fideos, zapallo italiano, papas enteras y espinacas. - Leche con vainilla (tibia)	- Brownie. - Cereales Pillows. - Tomaticán y ½ de sopa de pavo y fideos (mezcladas). - Leche con vainilla. - Alfajor de chocolate con manjar. - Agua de manzana. - Algodón de azúcar. - Leche en caja. - Galletas Oreo. - Sopa de pollo con arroz, pastel de choclo. - Compota de plátano.	- Leche de frutilla. - Yoguito de frutilla. - Sopa de carne con sémola. - Compota de avena (plátano/arándano). - Leche de vainilla (vaso). - Yogurt de frutilla. - Sopa casera (sémola, vacuno, arroz, papa, zanahoria). - Compota de plátano. - Leche de vainilla (vaso). - Galletas Oreo (3).

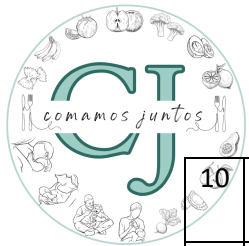
	Alimentos que rechaza completamente
	Alimentos que acepta medianamente o con los cuales reclama al comer.

Lista actual de alimentos consumidos:

	Alimento	Observación
1	Sopas	Arroz, papas, zapallo amarillo y zapallo italiano, sémola, tomate, apio.
2	Proteínas	Carne, pollo, pavo estas se presentan en la sopa
3	Legumbres	Lentejas, garbanzos, porotos en sopa o pure
4	Picados	Nestlé (pastel de choclo, Tomaticán, carne-arroz- zanahoria y cazuela de ave o carne)
5	Galletas	Oreo, tritón, morocha
6	Dulces	Brownie, huevos de chocolate, Nutella
7	Leche	Vainilla, frutilla y chocolate
8	Nestum	Con leche
9	Yogurt	Frutilla y vainilla y 1+1 choco krispis. Zero lacto.

Espacio terapéutico **Sisu**

Área de Conducta alimentaria y desafíos en alimentación
comamosjuntos.antof@gmail.com
Antofagasta



10	Compotas	<i>Arándanos con avena, plátano, manzana, pera y manzana, manzana con canela</i>
11	Flan	<i>Chocolate y Nutella.</i>
12	Yoguito	<i>Frutilla y vainilla</i>

Alimentos Aceptados / Rechazados:

Gustavo cuenta con una lista de alimentos aceptados inferior a 15. Dentro de sus papillas, cremas, sopas, se incluyen grupos de alimentos como proteínas, vegetales, carbohidratos, legumbres. Ahí se observa el primer desafío, ya que tiene esa consistencia de los alimentos como preferencia para las comidas principales del día. Por otro lado, se observa en su rutina, aceptación de lácteos y snacks de preferencia dulces sin aporte nutricional con alto contenido de azúcar. Esto último se consume de manera diaria y más de dos veces al día. No acepta frutas ni verduras crudas, no muestra preferencia por sabores más intensos o salados, evita alimentos sólidos (nutritivos), evita olores de alimentos, hasta el punto a veces de pararse de la mesa. Los sólidos que acepta son dulces y fáciles de gestionar en la boca.

Dentro de los alimentos que la madre menciona que Gustavo dejó de comer, se encuentran; *Plátano entero o molido, manzana molida, cereales pillows, cookies.*

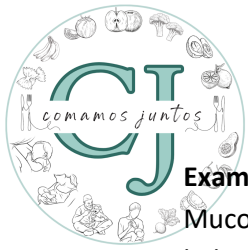
Conductas de Rechazo:

Madre refiere que en casa Gustavo generalmente rechaza los alimentos indicando de forma verbal que no le gustan, mira hacia otro lado, se arranca o esconde, echa la silla hacia atrás; cambia de tema y desvía la atención hacia otra cosa. Cuando siente olores que no son de su agrado se aleja, lo mismo ocurre cuando ve comida en la mesa que no le gusta, además cuando en su comida quedan trozos enteros del alimento los escupe e incluso vomita cuando no mastica los trozos, esto también ocurre cuando su comida cambia la textura o de color. Durante las sesiones de evaluación al presentarle un alimento que no es de su preferencia (zanahoria, pan de molde integral) Gustavo inmediatamente señala que no le gusta y que no lo quiere comer, sin embargo, mediante el juego Gustavo logra acercarse a los alimentos, logra tocarlos, logra tocarlos con sus labios, cuando llega el momento de llevarlo a su boca comienza a decir que no quiere y buscar realizar otra actividad.

❖ ANÁLISIS DE MOTRICIDAD OROFACIAL

Análisis Facial:

Labios en posición habitual se encuentran cerrados, forma de ambos labios es normal, se observa mucosa externa normal. Referente a musculo masetero en reposo mediante observación visual se logra percibir relajado, en reclutamiento durante la contracción isométrica (mordida sostenida) no se puede evaluar, ya que el menor no se condiciona.



Examen Intraoral:

Mucosa interna de labio es normal, frenillo superior no se logra observar, lengua en posición habitual no se logra observar. Referente a la simetría, ancho y altura de la lengua estos son adecuados, mucosa normal y frenillo adecuado. Mejillas y paladar duro son normales, presenta dientes en etapa decidua (dientes de leche).

Hábitos Orales no saludables: Respecto a los malos hábitos orales MHO, la madre refiere que Gustavo muerde objetos y se come las uñas.

Movilidad y Tonicidad Órganos Fonoarticulatorios:

Referente a la movilidad de los órganos fonoarticulatorios Gustavo logra abertura de boca, pero esta abertura es reducida, en cuanto al cierre de boca este es normal. No logra realizar lateralización de mandíbula. Referente a los movimientos labiales logra protrusión y retracción con labios cerrados y abiertos, no realiza lateralización de labios. En cuanto al movimiento lingual Gustavo logra protrusión de la lengua sin dificultad, logra lateralización de la lengua con alteración discreta, logra chasquido. En cuanto a la tonicidad de los músculos, no se logra realizar la evaluación, ya que Gustavo no se condiciona manifestando rechazo al toque de su cara mediante la verbalización “no quiero”.

Funciones Orofaciales:

Respiración: Gustavo presenta un tipo respiratorio costal inferior y modo nasal.

Masticación y Deglución:

En cuanto a la **masticación** esta se evalúa mediante registro audiovisual solicitado a los padres y en sesiones de evaluación se infiere lo siguiente. Gustavo logra cortar sus alimentos (incisión) con dientes delantero, concerniente a la fase de trituración de los alimentos, esta es realizada por los molares(muelas), lo cual está dentro de lo esperado. Referente al ciclo masticatorio Gustavo presenta un ciclo de masticación vertical, por lo cual los movimientos generados por su mandíbula no son rotatorios y el bolo alimenticio no se puede mover de un lado a otro de forma correcta. Además, presenta un patrón masticatorio unilateral preferente lado derecho, esto indica que siempre utiliza para iniciar y mantener la masticación solo por el lado mencionado, sin generar movimientos de lateralización de lengua. No se observa escape de alimento por boca, velocidad de masticación adecuada, no se logra observar masticación ruidosa. Es importante señalar que este ítem se evaluó en sesión con galletas, ya que en el registro audiovisual todas sus comidas son en formato papilla o picados, los cuales no permiten observar la adecuada realización y desarrollo de la función masticatoria.

En **deglución de solidos** Gustavo presenta postura de labios cerrados, postura de lengua entre los dientes, retención de los alimentos adecuada; al momento de llevar su papilla a boca, Gustavo lo



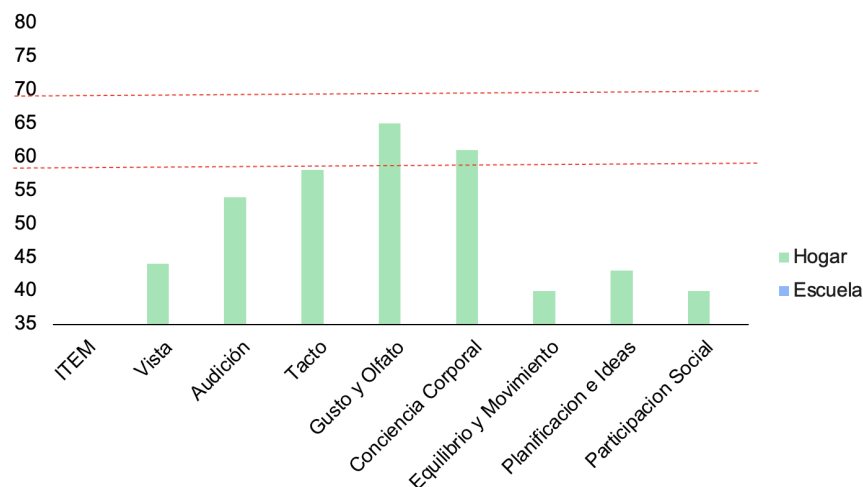
mantiene dentro de ella por varios segundos moviendo el alimento, para posteriormente tragarlo, esto se logra observar tanto en sesión de evaluación como en registro audiovisual, además presenta leve contracción de músculos orbicular al momento de deglutir. No presenta movimientos de cabeza, ruido y residuos después de deglutir. En cuanto a la evaluación de **deglución con líquidos** no se observan dificultades.

❖ ANÁLISIS DE PERFIL SENSORIAL Y OBSERVACIONES CLINICAS DE INTEGRACIÓN SENSORIAL

ANÁLISIS DE PERFIL SENSORIAL (SPM-2)

El procesamiento sensorial es un proceso neurológico en el cual se procesa, integra, selecciona e inhibe información de los estímulos sensoriales entregados por mi propio cuerpo y el entorno para dar una respuesta adaptativa de acuerdo a las demandas del entorno. En otras palabras, es el proceso en el que el cerebro decide qué información usar y cómo usarla para poder actuar adecuadamente en las actividades del día a día, como comer, jugar, participar de clases, interactuar con otros, etc.

Resultados Obtenidos SPM – 2 HOGAR			
Ítems	Puntaje bruto	Puntaje T	Interpretación
Visual	13	44	Rango típico
Audición	16	54	Rango típico
Tacto	17	58	Rango típico
Gusto y olfato	20	65	Dificultades moderadas
Conciencia del cuerpo	21	61	Dificultades moderadas
Equilibrio y movimiento	10	40	Rango típico
Puntaje sensorial total	97	56	Rango típico
Planificación e ideas	12	43	Rango típico
Participación social	11	40	Rango típico





A continuación, se detallan aquellas conductas que los padres observa con mayor frecuencia, las cuales hacen que el puntaje aumente. En dos ítems se obtuvo un resultado de desafíos o dificultades moderadas, dentro de las conductas destacadas, se encuentran:

Gusto y olfato: **Siempre** rehúsa probar comidas o bebestibles nuevos, insiste en comer solo ciertas comidas o ciertas marcas de alimentos, se angustia debido a sabores de comidas que a otros niños no les molestan. **Ocasionalmente** huele los objetos nuevos o las cosas antes de usarla, nota fragancias u olores que otros no notan.

Conciencia corporal: **Siempre** busca actividades que consisten en empujar, jalar o arrastrar. **Frecuentemente** muerde los juguetes, la ropa u otros objetos, derrama o vuelva las cosas en la mesa. **Ocasionalmente** tira las puertas al cerrarla o las empuja muy fuerte, salta de sitios en altura impactando sus pies con fuerza, juega con la mama y hermano de una manera demasiado brusca, pone demasiada comida en su boca.

A nivel táctil y auditivo se obtuvo un puntaje dentro del rango típico, sin embargo, destacan las siguientes respuestas:

Tacto: **Siempre** hace arcadas o vomita en reacción a comidas de ciertas texturas. **Frecuentemente** rehúsa comidas con mezclas de texturas como el yogurt con fruta.

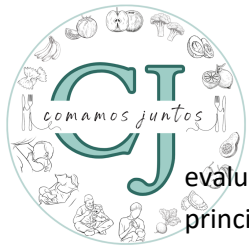
Audición: **Frecuentemente** se fastidia con sonidos caseros comunes, se sobresalta fácilmente cuando hay sonidos fuertes o inesperados. **Ocasionalmente** no responde cuando lo llaman por su nombre, le gusta hacer ciertos sonidos repetitivamente.

Observaciones Clínicas:

Gustavo es un niño con un nivel de actividad esperado para su edad y un nivel de alerta fluctuante. Participa del proceso evaluativo de manera activa y receptiva.

En relación al movimiento, acepta cambios de planos de movimiento, acepta despegar los pies del suelo, sube a columpios con ayuda, tolerando movimientos en diferentes direcciones, sube a balón, realiza actividades que requieren equilibrio. No presenta signos de aversión al movimiento y tampoco búsqueda de estímulos vestibulares. En relación a la conciencia corporal, se aprecia cierta dificultad con la precisión de algunos movimientos simples, utiliza generalmente más fuerza de la necesaria para la tarea, tanto motriz gruesa como fina, se apoya mucho del sentido de la vista para imitar posturas o mantener el equilibrio. Cierta dificultad con cruce de línea media. Se observa desempeño grafomotor durante las actividades y realiza una prensión palmar (no acorde a su edad) con baja calibración de la fuerza. Gustavo presenta un menor control postural en algunas situaciones de juego, bajas reacciones protectoras y de equilibrio.

A nivel táctil pese a que en el cuestionado SPM se obtiene un resultado en rango típico, hay conductas que se destacaron anteriormente, sumado a ello, se puede mencionar que en la



evaluación Gustavo si mostro algunos signos de menor modulación ante estímulos táctiles, principalmente residuales, no le gusta ensuciarse, mantiene las manos hiperextendidas en muchas ocasiones en que se ensucia ya sea con comida u otros elementos. Sin embargo participa de igual manera en las actividades.

SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN

Gustavo Araya (4años) asiste a evaluación Multidisciplinaria (Terapia Ocupacional- Fonoaudiología) por motivo de dificultades en su conducta alimentaria. En base a la evaluación realizada se puede mencionar lo siguiente:

Respecto a la conducta alimentaria, se registra que Gustavo tiene un listado de alimentos inferior a 15, considerando preparaciones y alimentos consumidos (no ingredientes por separado). Consume alimentos preferentemente tipo papilla, crema o picados envasados, en ellos se incorporan carbohidratos, proteínas, verduras y granos. No tiene dificultad con el consumo de líquidos. Los alimentos sólidos que consume son azucarados, no nutritivos y de fácil gestión en la boca. No consume verduras crudas y tampoco frutas (excepto plátano ocasional). Rechaza de manera verbal y gestual, diariamente está expuesto a presión para probar, carece de una rutina diaria que estructure y anticipe los horarios de alimentos, a su vez que favorezca señales de hambre/saciedad. Durante las sesiones de evaluación se observan conductas ansiosas por parte del menor, ante la exposición a alimentos que no son de su agrado, indicando de manera repetitiva que no le gusta y que no quiere probar incluso antes de dar las instrucciones de la actividad, además al momento de solicitar tocar el alimento con su boca comienza a evitar inmediatamente el alimento y buscar llevar la atención hacia otra actividad, aumenta su estado de alerta, se inquieta, incluso evita el contacto visual con el alimento en varias ocasiones. |

Referente al procesamiento sensorial, Gustavo presenta signos asociados a una mayor responsividad táctil (reacciona con aversión, desagrado o temor, ante estímulos táctiles que a otros niños no les molestan) tanto con elementos residuales en situaciones de juego, como con alimentos. Gustavo cuenta con habilidades compensatorias. Se observa un menor control postural, bajas reacciones de equilibrio y protectoras, se observa búsqueda propioceptiva en situaciones de mayor “estrés”, baja calibración de la fuerza, dificultad en cruce de línea media o actividades que requieran mayor coordinación de ambos lados del cuerpo. Lo anterior puede hacer que la hora de comer, pueda ser más desafiante, observándose inquietud motriz, dificultad para mantenerse sentado en la mesa, evitación de estímulos táctiles, aumento del nivel de alerta, menor manipulación de utensilios para comer o baja eficiencia en su manipulación.

Respecto al área fonoaudiológica, luego de la evaluación miofuncional orofacial, se puede constatar que Gustavo presenta patrones adaptativos atípicos, los cuales generan un **Desequilibrio**

Espacio terapéutico **Sisu**

Área de Conducta alimentaria y desafíos en alimentación

comamosjuntos.antof@gmail.com

Antofagasta



Miofuncional Orofacial caracterizado por deglución disfuncional (atípica) de tipo interposición lingual, ciclo con tendencia a la verticalización y patrón preferente unilateral derecho. Estos patrones adaptativos atípicos surgen a la ausencia de patrones normalizados dentro del complejo orofacial, generando patrones de movimientos alterados a nivel mandibular, labial y lingual, afectando la función orofacial de la masticación y deglución.

Con relación a las áreas de la fonoaudiología del lenguaje, comunicación Gustavo presenta habilidades de comunicación, lenguaje y habla acorde a su edad cronológica.

Factores Predisponentes	Factores Precipitantes	Factores Sostenedores	Factores Protectores
☐ Historia Clínica. ☐ Edad. ☐ Temperamento. ☐ Desequilibrio miofuncional. ☐ Desafíos sensoriales a nivel oral. ☐ Desafíos en el procesamiento sensorial.	☐ Oferta diaria similar. ☐ Exceso de atención. ☐ Presión/estrés. ☐ Estilo de crianza.	☐ Ausencia de rutinas a la hora de comer. ☐ Uso de distractores. ☐ Oferta de alimentos reducida. ☐ Presión constante. ☐ Escasas oportunidades de comidas familiares. ☐ Baja participación en actividades relacionadas.	☐ Participación del proceso por parte de los padres. ☐ Intereses variados. ☐ Habilidades motoras gruesas. ☐ Manejo de vocabulario relacionado a la hora de comer y alimentos. ☐ Verbalizaciones. ☐ Consumo de agua.

SUGERENCIAS GENERALES

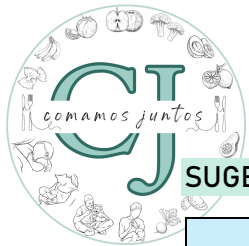
- ☐ Se recomienda intervención de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología por un mínimo de 12 sesiones, bajo metodología de dupla, es decir, atención con ambas profesionales a la vez, para abordaje global de los desafíos que impactan la conducta alimentaria actual.
- ☐ Se recomienda control con Nutricionista, para conocer el estado nutricional (más allá del peso y talla), y a la vez apoyarnos en la reorganización de alimentos en la rutina diaria. Esto también permitirá manejar de mejor manera el estrés parental.

Espacio terapéutico **Sisu**

Área de Conducta alimentaria y desafíos en alimentación

comamosjuntos.antof@gmail.com

Antofagasta



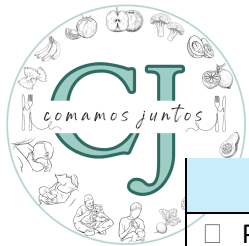
SUGERENCIAS RELACIONADAS AL MOTIVO DE CONSULTA

Reducción del estrés a la hora de comer:

- ☐ Disminuir expectativas iniciales como padres, lo que implica que, al momento de ir a la mesa, no pretendamos que pruebe algo obligatoriamente, la frustración en los adultos es completamente válida y empatizamos con ello, pero también es percibida por los niños.
- ☐ Evitar decir: prueba esto, está rico, que delicioso, que asqueroso, te va a gustar, etc. estas conductas son percibidas por los niños como presión y a la vez generan una predisposición negativa hacia los alimentos.
- ☐ La atención en la mesa debe estar puesta en la comida y NO en el niño. Podemos hacer comentarios aludiendo al alimento, como, por ejemplo: *“mmm esto está muy dulce”, “guau este alimento tiene sonido”, “mmm se parece al cereal que comes a veces”*.

Generar una rutina a la hora de comer:

- ☐ Anticipar la hora de comer de manera verbal, por ejemplo: *“en 10 minutos es hora de ir a la mesa”*, apóyese de algún reloj visual, alarma con sonido y/o apoyo visual.
- ☐ Acompañarlo a lavarse las manos, utilizar esta instancia para brindar experiencia sensorial previa. Por ejemplo; puede utilizar jabones con distintas fragancias, un día lavar las manos con agua fría, al otro con agua tibia, secarse con toallitas de diferentes texturas, etc. Luego de esto pueden realizar algún pequeño juego social que lo motive a ir a la mesa.
- ☐ Hacer participe a Gustavo de la preparación de su mesa. Dar instrucciones simples, como; *“toma, lleva la cuchara a tu mesa”, “toma, lleva este vasito a la mesa”*.
- ☐ Utilizar señales visuales que le indiquen al niño que es la hora de comer. Ejemplo; utilizar un mantel a la hora de almuerzo y cena, esto indica que cuando está el mantel puesto, es hora de compartir entorno a la comida, no es hora de juego ni tarea.
- ☐ Realizar rutina de limpieza (que incluye botar residuos en una bolsita proporcionada por un adulto, limpiar su mesa, etc.) actividad que indicará el fin de la hora de comida. Ejemplo; si en su plato hay choclos, y ya es el fin, vamos a pedirle ayuda para botar cada choclo en la bolsita de basura (esto en el comedor). Una vez terminada la hora de comer, puede ir a lavarse las manos y jugar.
- ☐ La hora de comida no debe exceder **los 30 minutos**. Luego de ese tiempo, pueden esperar la hora de colación y volver a ofrecer alimentos.

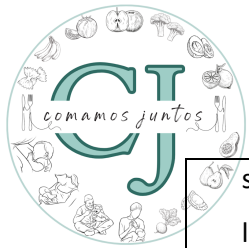


Potenciar espacios para la familiarización y exposición gradual

- ☐ Potenciar comidas familiares como experiencias de modelado. Idealmente el adulto que lo acompañe a comer también debe comer alimentos paralelamente, no en horarios diferidos. De esta manera Gustavo puede ver con mayor frecuencia cómo come otro, el disfrute, puede favorecer imitación en la interacción, imitación con uso de utensilios como vaso, cuchara, tenedor para pinchar.
- ☐ El adulto que acompaña debe tener en su plato al menos un alimento igual que en el plato del niño.
- ☐ Favorecer la exploración multisensorial de alimentos fuera de las horas de comidas principales. Realizar en casa actividades similares a las que se realicen en las sesiones, realizar juegos que involucren alimentos.
- ☐ Pueden realizar momentos de picnic en el living, donde todos coman en el suelo alrededor de un mantel simulando un picnic.
- ☐ Ya que le gusta el agua podemos solicitarle ayuda para lavar algunas verduras y/o frutas.
- ☐ Cuando vayan con él al supermercado, le podemos pedir ayuda para guardar los alimentos en la bolsa.

Potenciar posibilidades en las horas de alimentación

- ☐ Definir responsabilidades. Madre/padre son responsables de **QUÉ/CUÁNDO/DÓNDE** comer, mientras que Gustavo decide **QUÉ y CUÁNTO** comer de lo que se le ofrece.
- ☐ El **QUÉ** tiene relación con la oferta de comida, esta debe comenzar a ser más variada, idealmente se recomienda un plato al menos con 3 divisiones, para evitar ofrecerle solo el alimento seguro y habitual, no importa que no coma de los 3 alimentos, lo importante es que con frecuencia acepte variación frente a él. (se recomienda ofrecer una proteína, un almidón, una fruta y una verdura gradualmente).
- ☐ El **CUÁNDO**, tiene relación con los horarios, estos deben permitir un periodo de tiempo en el que no haya picoteo u oferta, al menos 2 horas entre comidas. Ejemplo: si la colación de la mañana fue a las 11:00 no debe ofrecer almuerzo hasta las 13:00 hrs. Idealmente debe generarse una rutina que se puede respetar tanto en la semana como fin de semana, es decir, debiese almorzar siempre en el mismo rango horario, lo mismo debe ocurrir con las colaciones y cena, para que

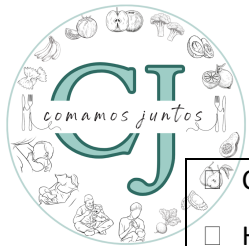


su cuerpo vaya adaptando también un hábito y se favorezca la sensación de hambre y saciedad, lo cual es difícil de favorecer cuando la dieta sacia muy rápido con un alto contenido de azúcar.

- ☐ El **DONDE**, tiene relación con el lugar en que se ofrece la comida. Si bien, come en el comedor, de debe ajustar la silla para que Gustavo quede con la espalda recta y no inclinado hacia atrás.
- ☐ Antes de comer, ofrecer sorbos de agua con hielo o muy fría, para activar la boca y brindar mayor input sensorial en ella.
- ☐ Disminuir la oferta de alimentos azucarados.
- ☐ Reducir el consumo de lácteos previo a horas de comidas importantes.
- ☐ Variar la oferta, ofrecer al menos 1 alimento nuevo, junto a sus comidas habituales en porciones pequeñas. Este alimento nuevo debe tener similitud con los que ya come, color y consistencia similar, también puede algo diferente para que flexibilice tenerlo cerca, pero presentarlo de manera constante. En caso de que no tolere tener algo “nuevo” en su mismo plato, disponer de un platito extra cerca, para que ella traslade lo que no quiere en su plato hacia el platito.
- ☐ Expandir los alimentos actuales hacia nuevos alimentos similares, Ejemplo: si come la compota envasada que tiene banana, al día siguiente ofrecer una compota natural con banana, hacer galletas en casa y bañarlas con chocolate derretido junto a él.
- ☐ Si le molesta lo que está comiendo uno de los padres, pueden utilizar barreras visuales en la mesa, como un florero pequeño entre su comida y la de él, si le molestan los olores, podemos comer con un pequeño ventilador, para que no se escape de la mesa, si no que se disipe el olor.
- ☐ Presentar el plato vacío o con un poco de alimento que le gusta, para que luego él vaya llenando su plato, sacando de pocillos que se encuentren al medio de la mesa, de esta manera se favorece el acercamiento a otros alimentos.

Favorecer un adecuado procesamiento sensorial

- ☐ Realizar actividades motoras intensas al menos por 20 minutos previo a que sea expuesto a una actividad con alimentos novedosos.
- ☐ La actividad motora puede ser mediante circuitos en casa, con elementos como cojines, sillones, colchón, sillas, etc. Idealmente debe incluir gateo, salto, carga y descarga de peso (caminar como carretilla), empuje, etc. Todo aquello que active mi musculatura, incluso pueden jugar al sándwich aplastándolo con cojines.
- ☐ Salir al parque algunas mañanas o tardes en la semana, antes de llegar a casa a comer.



Continuar con el uso de cepillo eléctrico.

- ☐ Hacer actividades táctiles, con diferentes texturas, como buscar objetos dentro de masas, o dentro de bolsas cerradas, llenar globos con harina o porotos para que pueda estirar y apretar. Esto previo a hacer una actividad más dirigida.
- ☐ Cuando se utilice la silla normal del comedor, permitirle movimiento mediante una banda elástica en las patas de la silla.
- ☐ Realizar actividades con alimentos que requieran uso de fuerza, calibración de fuerza y precisión, como por ejemplo; trasvasiar jugo o agua de un jarro a vasos, exprimir limón, exprimir naranjas, abrir huevo, pelar huevo duro (aunque no sea para él), pinchar con el tenedor trozos de apio y dejarlos en un pocillo, etc. Esto favorecerá habilidades motoras finas.

Espacio terapéutico **Sisu**

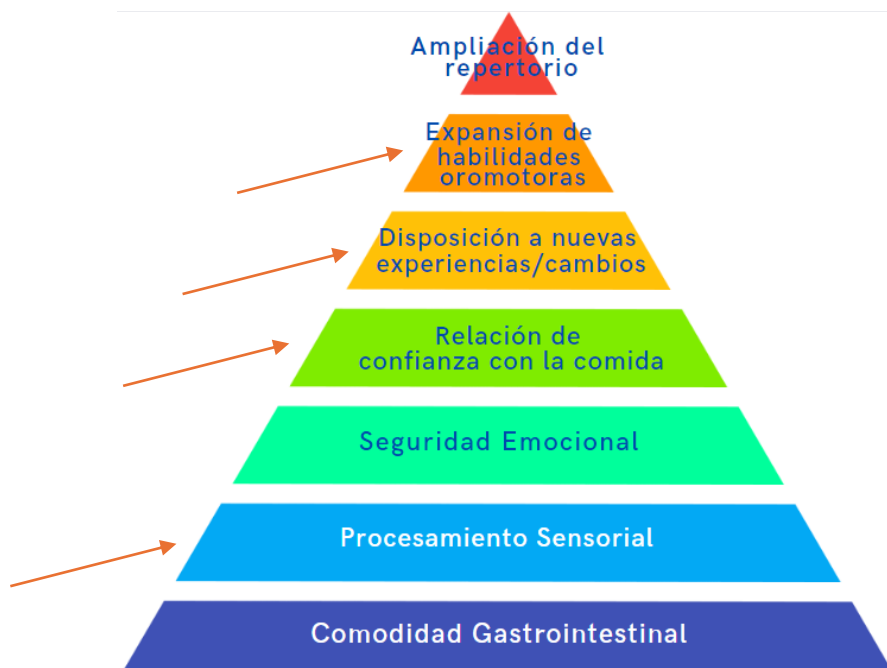
Área de Conducta alimentaria y desafíos en alimentación

comamosjuntos.antof@gmail.com

Antofagasta



Es importante tener en consideración la pirámide que se muestra a continuación, al momento de decidir iniciar tratamiento, ya que, se invita a la familia a ser un equipo en conjunto con el/la Terapeuta Ocupacional y Fonoaudióloga. Existe un trabajo individualizado realizado en las horas de terapia, sin embargo, es crucial que en el hogar se refuerce y generalice lo trabajado, es importante crear oportunidades y experiencias positivas en el hogar, ya que, es allí donde su hijo se desenvuelve la mayor parte del tiempo y es la madre/padre/familiares las personas con mayor significado emocional para él. **Nuestro primer objetivo NO será la ingesta de alimentos EN TERAPIA, se requiere trabajar otros aspectos previamente, para formar una base lo mayormente sólida, dentro de lo posible, para potenciar otras habilidades del desarrollo.**



Sin más que informar se despide atentamente.

19 de febrero 2025

Claudia Torrijos Cabello
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Esp. Certificada en Integración Sensorial USC
Certificada en SOS approach to feeding nivel avanzado
Rut: 17.693.429-8
N° Registro 407553

Daniela Soto Montes
FONOAUDIÓLOGA
Terapia Miofuncional Orofacial
Rut: 17.018.585-4
N° Registro Minsal 577413